

LES PÉRITONITES

Table des matières	
Objectifs pédagogiques:.....	1
I.Définition-Généralités	1
II.Classification.....	2
III. Bases anatomiques.....	2
IV.Physiopathologie	2
V.Etude sémiologique.....	3
Signes fonctionnels :.....	3
Signes généraux :	3
Signes physiques :	3
VI.Examens complémentaires	3
VII. Étiologies.....	4
VIII. Évolution.....	5
IX.Conclusion :.....	5
Références bibliographiques.....	5

Objectifs pédagogiques:

1. Connaître les signes d'une péritonite aigue
2. Citer les causes de la péritonite aigue

I.Définition-Généralités

Les péritonites aiguës se définissent comme des inflammations ou des infections aiguës de la séreuse péritonéale; le plus souvent secondaires à la perforation d'un organe digestif et /ou à la diffusion d'un foyer septique intra abdominal. Elles peuvent être soit généralisées dans la grande cavité péritonéale, soit localisées dans les loges sousphréniques, les gouttières pariéto-coliques et le cul de sac de Douglas. La réaction locale puis générale peut rapidement entraîner le décès. Le diagnostic doit donc être rapide et le traitement est une urgence chirurgicale.

II. Classification

Parmi les différentes classifications des péritonites, celle dite de Hambourg qui sépare les péritonites en trois classes selon l'origine de l'infection est la plus utilisée. Les péritonites secondaires représentent 90 % des péritonites aiguës.

1. Péritonite primaire : Les péritonites primaires sont dues à une infection spontanée mono bactérienne du péritoine d'origine hémotogène ou par translocation. Leur traitement est médical. Les causes les plus fréquentes sont l'infection d'ascite à *E. coli* chez le cirrhotique, l'infection à staphylocoque par l'intermédiaire du cathéter chez les patients avec dialyse péritonéale et la péritonite spontanée à pneumocoque de l'adulte.
2. Péritonite secondaire : Les péritonites secondaires sont liées à la diffusion d'une infection abdominale localisée ou à la perforation d'un viscère digestif.
3. Péritonite tertiaire : Les péritonites tertiaires correspondent à des infections abdominales persistantes malgré un traitement bien conduit (antibiothérapie adaptée et éradication du foyer primitif abdominal par une ou plusieurs interventions). La cavité abdominale est surinfectée par des micro-organismes peu virulents mais devenus résistants ou des levures. Ces péritonites sont fréquemment associées à un syndrome de défaillance multiviscérale.

III. Bases anatomiques

Le péritoine est une membrane séreuse vascularisée et innervée comportant deux feuillets : un feuillet viscéral enveloppant entièrement ou partiellement tous les organes digestifs un feuillet pariétal tapissant les parois de la cavité abdominale. Ces deux feuillets déterminent une cavité virtuelle: La cavité péritonéale

IV. Physiopathologie

- Contamination bactérienne hémotogène
- Contamination péritonéale de dehors en dedans :Ex : traumatisme pénétrant
- Contamination péritonéale de dedans en dehors :Ex : perforation d'organes intraabdominaux.

a/Mécanismes :

➤ Les péritonites primitives :

Elles sont très rares (1-2 %) et surviennent en l'absence de foyer infectieux intraabdominal primitif: Inoculation par voie hémotogène du liquide péritonéal ,au cours d'une bactériémie.

Une infection du liquide d'ascite, spontanée ou après un geste de drainage chez les cirrhotiques++ Les germes retrouvés sont le pneumocoque et le streptocoque, surtout chez l'enfant, et le bacille de Koch.

➤ Les péritonites secondaires :

- perforation d'un organe creux (estomac, duodenum, grele et côlon),
- rupture d'un abcès en péritoine libre (abcès appendiculaire, abcès péricolique, pyosalpinx,...) diffusion d'un foyer infecté local (appendicite, salpingite, sigmoïdite, cholécystite...).
- Par plaie pénétrante
- Post opératoire

b/Retentissement :

➤ local:

✓ Le péritoine se défend par l'exsudation d'un liquide sérofibrineux (3ème secteur) avec de fausses membranes

✓ Accollement des viscères à l'épiploon et à la paroi.

➤ Répercussions systémiques :

- diffusion septicémique par résorption des germes et de leurs toxines: défaillance multi-viscérale:
- collapsus cardio-vasculaire par choc septique et hypovolémie défaillance respiratoire
- insuffisance rénale liée à l'hypovolémie

V. Etude sémiologique

— Les signes communs de péritonite aiguë :

Indépendamment de l'étiologie, une symptomatologie commune permet de porter le diagnostic de péritonite : c'est le syndrome péritonéal.

• Signes fonctionnels :

- Douleur abdominale : constante, permanente, augmentée par les mouvements, la toux, l'éternuement, l'effort de défécation et la palpation : toutes les manœuvres qui augmentent la pression intra-péritonéale. Cette douleur est d'abord localisée, le siège initial de la douleur est important car il peut permettre de reconnaître la cause, puis la douleur est secondairement généralisée à tout l'abdomen;
- Vomissements : inconstants;
- Troubles du transit : constipation, parfois arrêt des matières et des gaz en rapport avec un iléus réflexe (occlusion intestinale fonctionnelle).

• Signes généraux : la fièvre dont l'heure d'apparition varie avec la cause, le pouls est accéléré.

• Signes physiques :

- Inspection : abolition de la respiration abdominale, parfois, il existe une rétraction de l'abdomen;
- Palpation : met en évidence un signe majeur : la contracture abdominale qui possède les caractères suivants : elle est douloureuse s'accompagnant d'une hyperesthésie cutanée, elle est localisée au début puis généralisée, elle est invincible, permanente et irréductible, réalisant le classique « ventre de bois ». Les signes accompagnateurs sont les suivants :
- Abolition des réflexes cutanés abdominaux;
- Douleur vive déclenchée au niveau du cul-de-sac de Douglas par le toucher rectal: « cri du Douglas ». Il faut savoir que parfois la contracture abdominale peut manquer et être remplacée par une défense pariétale.

VI. Examens complémentaires

URGENCE chirurgicale : aucun examen ne doit retarder le diagnostic et la prise en charge thérapeutique.

a) Imagerie :

- Rx thorax : pneumopéritoine, Épanchement pleural
- ASP (clichés face debout prenant les coupes, de face couché et de profil couché):

- ✓ pneumopéritoine perforation d'un organe creux : croissant clair interhépatodiaphragmatique sur le cliché debout de face.
- ✓ iléus réflexe (distension aérique du grêle et du côlon, niveaux hydroaériques....)
- Echographie: Épanchements péritonéaux, abcès
- Transit aux hydrosolubles : visualise la perforation gastrique ou colique.
- PONCTION / LAVAGE DU PÉRITOINE : A vessie vide, les résultats dépendent de l'étiologie:
 - ✓ Liquide clair
 - ✓ Liquide hématique
 - ✓ Liquide fécaloïde
 - ✓ Liquide purulent
 - ✓ Liquide bilieux.
- Scanner abdomino-pelvien

Il est utile lorsque l'examen clinique est douteux (immunodéprimé, péritonite asthénique du vieillard) ou difficile (obèse, péritonite post-opératoire, traumatisé de l'abdomen). Il peut aider au diagnostic en mettant en évidence un petit pneumopéritoine non visible sur les radiographies standard ou un épanchement liquidien intra-abdominal. Il peut également montrer des signes liés à la cause : diverticulite, infiltration périappendiculaire.

b) Examens biologiques :

FNS, CRP, bilan rénal, bilan d'hémostase, ionogramme sanguin : Ils n'ont aucune valeur diagnostique. Mais sont réalisés pour évaluer la gravité de la péritonite et le retentissement systémique et rentrent dans le cadre du bilan pré-opératoire.

VII. Étiologies

➤ Péritonite appendiculaire :

- Signes fonctionnels : douleur abdominale : à début progressif, dont le siège initial est la fosse iliaque droite ;
- Signes généraux : sont marqués, fièvre rapidement élevée à 39,5-40 °C, le pouls est accéléré en rapport;
- Signes physiques : la contracture abdominale est maximale au niveau de la fosse iliaque droite;
- Examens complémentaires : l'hémogramme montre une hyperleucocytose avec polynucléose neutrophile, l'ASP est en règle normal.

➤ Péritonite par perforation d'ulcère gastrique ou duodénal :

— Signes fonctionnels :

- Douleur abdominale : à début brutal, déchirante en coup de poignard, survenant en pleine santé apparente, de siège épigastrique, puis diffuse secondairement à droite et en bas. Il est indispensable de préciser l'heure d'apparition de la douleur;
- Vomissements : sont retardés et inconstants;
- L'interrogatoire recherche des antécédents de douleur ulcéreuse qui peuvent manquer.

— Signes généraux : la température est normale les premières heures, le pouls est parfois accéléré.

— Signes physiques : l'examen clinique va mettre en évidence deux signes fondamentaux:

- la contracture abdominale épigastrique ou diffuse à prédominance épigastrique;
- la disparition de la matité préhépatique mise en évidence par la percussion pratiquée sur le sujet en position demi-assise; elle traduit l'existence d'un pneumopéritoine.

— Examens complémentaires : l'hémogramme est normal dans les premières heures, l'ASP met en évidence le pneumopéritoine qui apparaît comme un croissant gazeux interhépatodiaphragmatique.

➤ Autres étiologies :

- Péritonites par perforation du grêle
- Péritonites par perforation colique
- Péritonites biliaires
- Péritonites d'origine hépatique
- Péritonite génitale
- Les péritonites urinaires
- les péritonites pancréatiques
- Les péritonites post-opératoires
- Les péritonites primitives

VIII. Évolution

Une péritonite non traitée a une évolution rapidement dramatique. Elle entraîne rapidement le décès par état septique sévère, ou syndrome de défaillance poly-viscérale.

IX. Conclusion : la péritonite aigue est :

- Urgence chirurgicale mettant en jeu le pronostic vital.
- Sémiologie : syndrome péritonéal (contracture abdominale^{***})
- Les examens paracliniques ne doivent pas retarder le diagnostic ;
- Les trois causes les plus fréquentes sont : ulcère perforé, appendicite compliquée et perforation de diverticule sigmoïdien.

Références bibliographiques

1. Rose Marie Hamladji. Précis de sémiologie. OPU Alger.
2. <http://campus.cerimes.fr/hepato-gastroenterologie/enseignement/item275/site/html/cours.pdf>
3. <http://e-semio.org/Gastro-enterologie#SR1227>
4. https://www.snfge.org/sites/default/files/SNFGE/Rubrique_Professionnels/abrege_hepat_o_gastro/abrege_d_hge_2012-chap29_item275.pdf
5. <http://dSPACE.univ-tlemcen.dz/bitstream/112/12490/1/les-peritonites-aigues.pdf>